COMITÉ DOCENCIA - SERVICIO INSTITUCIONAL HRM
mar, 3 feb 2026

0:19 - Academia investigación
Más información www.alimmenta.com Más información www.alimmenta.com Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya esperamos un rático que se conecten los profes que pueden y ya iniciamos. No nos demoramos mucho. Hola, doctora.

5:31 - Orador no identificado
Buenas tardes.

5:32 - Natalia Salas
Claro que sí.

13:25 - Academia investigación
Más información www.alimmenta.com Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Creo que vamos a dar inicio con las personas que se encuentran en la Universidad de Mexico y creo que los otros doctores se van a ir conectando progresivamente y pues sé que están ocupados. Así que no me importa, solamente quiero manifestarles y darles a conocer aspectos específicos respecto a los convenios de DOCENCIA-servicio y darles a conocer algunas situaciones que se han manifestado entre los comités en las universidades y es importante que... ...planes de mejora. Bueno, entonces acá para iniciar solamente quiero mostrarles... ...recordarles cuáles son los convenios de DOCENCIA SERVICIO que actualmente tenemos. ¿Qué tenemos pendiente? La universidad informó el ingreso de estudiantes, médicos internos y residentes. Aún está pendiente, hasta la próxima semana tenemos reunión con esta universidad para definir cuándo sería el ingreso y qué áreas específicas ingresarían por parte de ellos. La universidad Santo Tomás el día de ayer se inició y los institutos que se encuentran abajo hacen referencia auxiliar de enfermería, promotores de salud específicos. ¿Qué puntos de mejora quiero mostrarles de esto? El COMITÉ de DOCENCIA de SERVICIO con las universidades y las encuestas que son de carácter anónimo manifestado los estudiantes que han estado en la institución y de los que se encuentran actualmente. Lo primero, doctor, es que quiero manifestarle lo de la organización académica. Se describe que las revisiones de tema, a veces hay especialistas o de pronto no, hay esa comunicación tanto del estudiante como del especialista en donde refieren que se revisan tres o cuatro temas, en el mismo día. Por ende, pues ellos no tienen esa disponibilidad de tiempo, por así decirlo, pues precisamente por la carga asistencial de revisar tres o cuatro temas en un mismo instante. Entonces, no sé si en este punto les ha pasado a algunos de ustedes en sus servicios o hay algo por comentar en este aspecto. ¿Qué es lo que sí es claro, doctores? Hay un plan académico que fue el que yo consensué con ustedes el año pasado. No sé si se está cumpliendo a cabalidad o hay algo nuevo que reformar, que mejorar y de pronto tener este aspecto académico más organizado. Con los médicos internos.

20:19 - Academia investigación
¿No? Bueno, doctores, entonces la sugerencia entre las rotaciones en este aspecto es evitar la programación de revisiones académicas de 2, 3, 4 temas en un solo día. Pues la intención es que ellos revisen bien el tema. Sabemos que hay ciertas cualidades académicas en algunos, en otros no. Y, pues, al fin y al cabo, la idea es que existe un entrenamiento académico por parte de ustedes. Que sí es claro que en todos pues se han recibido muy buenas observaciones y les agradezco mucho por eso, sin embargo pues por SERVICIO y en todos los servicios si nos hacen esta observación de mejorar esta carga académica por día en cuanto a las revisiones de tema. Entonces nuevamente les pregunto si los planes académicos que se tienen ahorita, ¿se requieren renovarse o ustedes consideran que los sigamos iguales?

21:23 - Oscar Lopez
Hola, pues por parte de Medicina Interna, ¿qué hice yo? A raíz de que algunos internos sugieren en sus notas, o sea, las notas que pasa uno en sus notas que muchos docentes no no tenían como la disponibilidad o que se hacían en otro momento hasta dos o tres revisiones como bien lo hizo la doctora Toledo. Yo quedé a organizar con ellos todas las revisiones personalmente, o sea, el que queda a cargo

de las revisiones soy yo. Yo había puesto a los colegas que me colaboraran dándole como los temas principales de medicina interna, pero creo que este semestre cambié esa metodología y los voy a hacer yo. Diciembre fue un mes un poquito complicado para la revisión con los internos. Enero tengo que decir personalmente no sé cómo están las otras especialidades con el horario hasta las 3 de la tarde siento que hay como un desligue porque nosotros la carga asistencial que tenemos siempre es un poquito pesada entonces uno espera como al final de la tarde cuando ya todo está compensado hacer las revisiones en ese espacio. Las demás áreas como estén, pero por ejemplo medicina interna pues digamos que yo busco sobre las 5 de la tarde, entonces algunos internos me decían, doctor qué pena con usted pero es que mi turno va hasta las 3 de la tarde, entonces sí quería hablar de ese tema para ver si de pronto pues organizarla, no sé, en el momento en el que ellos tengan las 12 horas, pero como tenemos rotantes que ya pasaron por la especialidad pues los temas básicos ellos ya los vieron en el semestre anterior, entonces con ellos la metodología es cambiarla a otros temas digamos como un poquito más profundos de la especialidad o a temas que ellos quieran reforzar, no hacerlos obligatoriamente volver a mirar los temas base de medicina interna, de mi lado es eso.

23:32 - Academia investigación
Listo, que importante lo que Sumersey comenta respecto a los horas Yo les dije a todos que pues era una prueba ensayo error de cómo nos iba en diciembre con este ajuste de horarios, pero ya para febrero y de aquí en adelante, los turnos quedaron de 12 horas. Los fines de semana ustedes van a encontrar que así aparece de 10 horas, porque precisamente debemos cumplir dos cosas, 66 horas semanales y 264 horas mensuales. ¿Sí? Obviamente, pues, ¿qué desfavorece? Pues, cuando sin festivos, cuando tenemos los 31 días, entonces es un poco más complejo organizar. Sin embargo, procuré que en el mes de febrero y mes de marzo, que es en el cronograma que yo les envié, pues evitáramos estas dificultades y pues la observación que sumerce dice de que se tenga que ir más temprano. Sin embargo, se iban a encontrar en muy pocos días, sobre todo medicina interna, aquel que se encuentra en hospitalización, su turno quedó de 7 a 5, mientras que el que se encuentra en urgencias está de 7 a 7, ¿sí? Y esto pues permitió favorecer y cumplir pues la normativa en sí. Pero si es correcto doctor, ya sé la semana pasada hablé con ellos en relación a eso y pues se estableció que pues desde un principio, desde el momento que yo pues estableciera los días en que se va a revisar, qué temas se va a revisar. Sin embargo, la observación es que no se revisen dos o tres temas en la misma jornada. Me refiero, revisar falla cardial de infección de vías urinarias el mismo día, ¿no? Porque al final o revisan uno, revisan el otro, y pues no lo hacemos en las condiciones que normalmente ustedes como docentes, pues, prefieren. Y también toca definir, doctores, la metodología del tema. Una de las observaciones de una de las universidades fue que realizar presentaciones, pues, no era como la mejor metodología o estrategia, o hacerla en todas las revisiones de tema. O sea, algunas de pronto con presentación, algunas otras, pues, puede hacer alguna metodología diferente. Esa decisión sí la dejo en ustedes, pero sí tenerlo en cuenta, considerarlo en los momentos que revisen temas con los médicos internos. Entonces esa es la opción y gracias Oscar por lo que me estabas comentando. Sí, don DAVID. Hola doctora, ¿cómo están?

26:04 - DAVID LEONARDO SANCHEZ
¿Cómo están a todos? Bueno, con el tema de la metodología es muy sencillo. Yo creo que el tema de las presentaciones y me corrige acá la doctora Leidy, que también es docente. Yo estoy formando DOCENCIA. Tiene que ser para los temas muy exclusivos. Si el resto se llama cuando uno estudia DOCENCIA uno sabe que hay diferentes formas de enseñar y esa forma de estar enseñando digamos con un tablerito o con una diapositiva, eso es puro conductismo. Estamos en una época en la cual ya todo es constructivismo, en el tema en el cual se va a hacer una mesa redonda, se debe opinar, se debe debatir, entonces yo creo que la universidad obviamente tiene toda la potestad para decirte eso, por lo Por la parte de cirugía general, estamos tratando de revisar temas por lo menos dos veces por semana. Se nos complicó muchísimo en diciembre y en enero, aunque yo te puedo asegurar que revisamos como 6, 7 temas con los internos de esos dos cortes, pero por la cuestión del trauma y de la ocupación del SERVICIO. Pero sí se revisó el tema. Pero la invitación a los colegas es que sea un tema. Bueno, todo el mundo tiene derecho a su metodología, pero los invito a que exploren lo que es el constructivismo en esa parte.

27:19 - Academia investigación
Sí, muchas gracias, Doc. Si es correcto y creo que es la metodología de la presentación debemos cambiarle. Yo sé que hay temas que requiere como entender conceptos y tenerlos muy claros. Obviamente, yo creo que se habla desde cada especialidad, desde cada área. Sin embargo, si de pronto de considerar en cuanto a la metodología, si es la mejor o si no, pues tener una alternativa y que no todos los temas sean de la misma manera. Forma de presentación. Sido, ¿Oscar?

27:50 - Oscar Lopez
Bueno, con respecto a lo que dice, pues sí es cierto que deberíamos como armarnos esas redondas y no sé qué invitación hagamos, todavía es partidario en que, por ejemplo, cuando hacíamos los ateneos, ahorita el inconveniente es que no tenemos auditorio, ¿sí? Pero que de pronto cuando tengamos la oportunidad de volver a tener el espacio, porque para mí eso forma adecuadamente al interno y nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas. DAVID lo sabe, los tres tal vez que tuvimos, dos que tuvimos en los semestres pasados, aprendimos mucho de esa socialización de los ateneos, entonces yo sí invito de pronto a que se busque otra vez el espacio para comentar los casos clínicos. O bueno, si no hay un sitio como tal, no sé, virtual o de alguna manera, que sea como algo de discusión, creo que nos forma a todos y nos nutre en cuanto a que a medida que tengamos los casos clínicos difíciles o digamos que se puedan hacer una correlación clínico-patológica, esos espacios sirven para la formación de ellos. Entonces, con respecto a lo que DAVID decía, me parece que las mesas redondas llevan también como a ese tipo de metodología que implementábamos hace mucho tiempo y que personalmente yo fui formado en ese tipo de metodología como en los ateneos en los casos clínicos en la cual teníamos discusiones no sólo de medicina interna sino en las diferentes áreas de opinada porque pues uno digamos que no se las sabe todas y entre más opiniones tenga mejor digamos que constructivismo como dices DAVID vamos a tener en cuanto al tema académico De acuerdo, Doc.

29:43 - Academia investigación
¿Qué pasó? O de pronto para que lo tengamos dentro de la mente o podamos resolverlo en este momento. El semestre pasado y los semestres anteriores en donde recolecta la información respecto a la realización de Ateneos o realizar un caso clínico diseñado por el médico interno y por el especialista, ¿qué se encontró? Hubo oportunidades o situaciones en las que tenemos que aceptar lo que médico interno buscó al especialista una semana antes, sabiendo con antelación que tenía que presentarse ese atenío. Segundo, pues en algunas situaciones de pronto desde las especialidades no se brindaba ese acompañamiento en el caso de los médicos internos que eran juiciosos y pues era un poco difícil establecer esa dinámica a los ateníos en sí. Tercero, pues no asistían, entonces llegaba el médico interno tarde, de pronto el especialista no podía asistir porque se presentó alguna situación de urgencia, de emergencia y es entendible, pero pues no sé si se deba proteger un espacio académico en que todos nos pongamos de acuerdo en relación a esto mismo. Y considero, por supuesto doctores, ahorita no contamos con auditorio, de hecho ese es el motivo también por el cual la metodología, las guías de práctica clínica este año se cambió pero pudiésemos establecer de una manera diferente en que todos podamos interaccionar. No tal vez cada mes, pero al menos una vez bimesual o trimesral. No sé si de pronto esa estrategia sea mucho mejor en vez de hacerla mensual y más porque yo sé que hay especialidades que precisamente ese día pasa de todo, sucede todo y genera dificultades tanto para que el especialista vaya como para que el médico interno asista. Entonces, No sé en cuanto a los atenidos, quiero establecer con ustedes y retomarlos este semestre, pero hacerlos pues puede hacerse virtual o podemos apartar inclusive la sala de juntas de la UCI, creo que lo podemos hacer sin ningún problema, pues porque tampoco somos 30 personas, pero pudiésemos proteger esos espacios, tal vez no de manera mensual, pero sí al menos dos veces cada semestre.

32:03 - Juan Camilo Morales Perez
Bueno, pues por mi parte, realmente las revisiones que se encuentran programadas dentro del tema que tratamos de proyectar desde el año pasado, pues en emergencias pasa una cosa y es que no hay interno permanente. Es una cosa que para el SERVICIO digamos que es un poquito difícil porque digamos que en los meses que se cuenta con el interno también digamos que la manera en que se retribuye el interés pues que ellos colaboran muchísimo a medida que están votando para el SERVICIO, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo quería proponer realmente, yo creo que Emergencias debería

hacer una votación obligatoria. Hay especialidades que tienen dos internos, tres internos y Emergencias en ocasiones no tiene y pues el trabajo de Urgencias es un trabajo que compromete todas las especialidades tanto básicas como derivadas, entonces pues yo lo dejo a consideración de ustedes que son quienes organizan esa parte, pero pues digamos que tienen un plus acá y es que tienen la especialidad de emergencias que no está en todo lado, entonces pues a medida que la quieran aprovechar, nosotros vamos a estar disponibles para apoyarlos en todo lo que se pueda. Frente a la metodología, estoy muy de acuerdo con DAVID, presentaciones en 2026. Eso no tiene cabida en ninguna cabeza, por lo menos pensante de la actualidad médica. Las revisiones, por lo menos por mi parte, se realizan. Ellos realizan una revisión, digamos que en su casa, en el tema y ya acá nos soltamos a hablar desde la fisiología hasta la fisiopatología y el abordaje, pero en ningún momento se plantea ningún tipo de realización de un escrito o de una presentación Porque realmente se ha demostrado que eso tiene muy baja evidencia. Y que realmente lo que ellos van a hacer cuando se hacen presentaciones es que van a cambiar las presentaciones que tenga otra persona, que me interna otra cosa. Entonces, eso no tiene mucha utilidad realmente. Yo creo que la metodología es, digamos que es ir siguiendo un camino con ellos e ir evaluando lo que ellos han revisado e ir soltando la información a medida que ellos tienen interés. ¿Por qué no a todos les interesa? Pues digamos que es lo mismo. Y frente a las revisiones de los Ateneos, pues es una metodología que se maneja acá en Bordacá. Realmente yo he tenido muy poco contacto con ellos, pero sí me parece que se realice una especie de gran sesión por lo menos una vez al mes por cada uno de los internos y pues eso tiene que ser algo por lo menos obligatorio donde ellos demuestren que logran hacer un abordaje y que unirán un tema y eso debería ser un requisito mínimo para poder avalar que la persona cuenta con la capacidad mínima de lograr hacer una presentación y desenvolverse en un escenario médico y un escenario académico y posiblemente dar una ponencia en otro sitio. Porque nos quedamos solamente con la pauta de las revisiones en la mesa o las revisiones cortas o pequeñas. Digamos que nunca los vamos a exponer a ellos a una presión alta de que ellos puedan dominar un escenario importante. Y realmente lo que uno busca cuando está dando educación de calidad es que ellos se destaquen en el área que a ellos les interesa, pero que se destaquen realmente, no simplemente que hayan llegado ahí por empujoncitos. Entonces yo creo que o tanto los Ateneos o las grandes sesiones o los club de revistas o cualquiera de todas estas estrategias en donde de manera individual ¿Qué es lo que es lo que es lo

36:11 - Academia investigación
que es lo que es lo que es lo que cierto y en la protección de ese espacio también la intención es que ustedes vayan y sobre todo como coordinadores asistan entonces no sé si programamos al menos o protegemos un día al mes un espacio específico para esto mismo y de manera que podamos contar con la asistencia de todos ellos y también opinen porque por supuesto es muy valiosa todas las intervenciones y pues ese apoyo y esa presión que su mercedes también a los internos creo que a todos nos pasó como residentes en algunos momentos, pues también debemos empezar ese proceso de formación con ellos, al menos hasta que lleguen los médicos, los residentes que también tenemos programados de la UICI. Bueno, que ellos también harán su sesión, pero debemos como proteger ese espacio. No sé qué día o qué momento del mes sea de pronto el más oportuno que todos podamos acordar, lograr al menos ir a la mayoría de esas sesiones. Alguno tenga de pronto dificultad de pronto dejamos los miércoles mayor facilidad perdón los miércoles o algunos viernes si no serán todos los viernes por supuesto pero al menos proteger uno o dos al mes para esto bien y podamos hacerlos creo que por este medio creo que por ahora pudiésemos hacerlo en este medio mientras tenemos un poco para todos. Yo considero, como dice Juan, que sí, que se debe rescatar eso para dar la parte formativa.

37:41 - Oscar Lopez
En realidad yo, pues, no sé, Juan, como líder de la parte de edificios, la parte académica, él viene miércoles y viernes, entonces yo creo que sí podría hacer en el espacio en el que él pueda asistir y estar presente. Mi propuesta, ¿cuál sería? Pronto hacerlo de manera virtual, pero al que le corresponde, digamos, la revisión, si es posible que ese día esté presencial, como con los muchachos en el auditorio de la UCI, se haga la presentación y se convoque de manera virtual a las especialidades que quieran ingresar o las personas que quieran ingresar. Ahorita los medios virtuales son de Y yo creo que muchas veces de esos casos clínicos o esas presentaciones pueden salir hasta publicaciones de casos o medios de investigación hasta para nosotros, para los muchachos como refuerzo. No sé qué opinan respecto a

eso.

38:55 - Academia investigación
No me acuerdo, no sé si les parece de pronto a todos, tal vez proteger el último viernes de cada mes. En horario de la mañana, si no podemos asistir presencialmente, pues al menos hacerlo por vía virtual y evidentemente tener sus valiosos aportes desde su área y. Doctora, qué hora de la mañana?

39:16 - DAVID LEONARDO SANCHEZ
Porque yo tengo COMITÉ primario todos los viernes del último, o sea, todos los últimos viernes del mes, pero pues No sé si esté bien como de 11 a 12.

39:28 - Academia investigación
El último viernes de cada mes que se pueda proteger por el parte perfecto. Por mi parte, también perfecto.

39:36 - Juan Camilo Morales Perez
Igualmente, yo creo que tiene que ser eso obligatoria la asistencia presencial para todos los internos. Eso no puede ser discutible. Ellos no deben conectarse virtual. Ellos tienen que estar presencial porque eso también muestra el compromiso para ellos. Y que ellos estén realmente conectados con el tema y con lo que se está brindando. Y por lo menos asegurar que haya un docente acompañante durante cada una de las jornadas. Eso sí, no lo podemos rotar o dejar un par asignados por si alguno de pronto se le presenta alguna cosa. Por lo tanto, no sé. DAVID tiene que irse a operar alguna cosa urgente. Yo puede que me ocupe. Sí, puede que pasa algo en Ginecologia, alguna cosa así. Entonces yo creo que debería tener estas dos características, ser híbrido pero esa característica de que sea híbrido tiene que estar limitada hasta un punto. Ellos deben estar presenciales en algunas sesiones y eso realmente tiene que ser algo mandatorio para que ellos sientan que eso es una gran sesión y que se incumplen con eso. Pues esto tiene que tener una... Pues nunca digo, ya no hablamos de castigos ni nada de esto, pero sí que tienen una implicación, que ellos noten que eso tiene un peso, una importancia grande para las revisiones grandes de la institución como grupo total de internos. Entonces, por mi parte, el horario no hay ningún inconveniente.

40:52 - Orador no identificado
Listo.

40:52 - Academia investigación
Yo apoyo también a Juan en eso.

40:55 - Oscar Lopez
Y pues digamos que de mi parte sí pueden quedar los viernes. Y si algún, pues digamos, la idea es que entre nosotros es como que nos demos a conocer los casos para que si, como dice Juan Carlos en ese momento, alguno se tiene que ir por una urgencia y tal o porque se representó alguna cosa, pues que quede pronto uno de nosotros a cargo, pero que conozca previamente cómo el desarrollo de la charla, del espacio, del Ateneo, para que oriente también al Internet si se llega a tener en algún momento alguna complicación. De mi parte, yo les puedo colaborar cuando lo necesiten y creo que ellos también si se nos llega a presentar alguno, la idea sería que entre nosotros conozcamos los casos y como que digamos cómo se quiere desarrollar la metodología para que pronto si alguno falta, el docente que queda a cargo provisional pues sepa desarrollar la metodología. Listo, sí señor.

42:05 - Academia investigación
Entonces teniendo en cuenta todas esas observaciones, presentaré como un documento guía tanto para nosotros desde la parte docente como para los médicos internos para ya empezarlos a comprometer y empecemos desde este mes. Entonces los organizaré a ellos progresivamente teniendo en cuenta que algunos continuarán fluidos acá con nosotros y los que ya están por finalizar y no han presentado nada pues ellos son los que vamos a priorizar para este semestre. Entonces les enviaré a más tardar esta semana cómo se va a realizar y cuál sería la actividad y quedo pendiente de sus observaciones para

también pues organizarlo dentro del documento. Eso en cuanto al primer punto que es la organización académica. Aprovecho de pronto en este punto que pues con algunos de ustedes tuve alguna charla y me decían lo siguiente, me decían doctora ¿por qué no retomamos se hace antes de que un día para gineco, un día para medicina interna, un día para pediatría, un día para cirugía general. Siento, o de pronto cuando hable también de este tema, creo que era como muy difícil lograr establecer una metodología y lograr un tiempo oportuno también en esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que está en gineco, que en gineco más o menos son 14 temas, me corregirá la doctora Charon, que sí han sido obligatorios en revisar pues de pronto se cruzaban con las revisiones de tema pues con otras áreas y otras especialidades y pues al fin y al cabo terminaban llegando a esa revisión sin revisar el tema de ese día por ejemplo electrocardiograma ni revisando lo de ginecología. Entonces yo les propongo y pues queda a consideración de ustedes también apoyar esta decisión si aparte del tema de los ateneos por su que ellos pues en parte de la revisión de las guías de práctica institucionales de la misma metodología eh que pues se va a llevar a cabo y una vez por mes se realice un taller con una especialidad diferente. Por ejemplo, este mes se va a realizar el taller con ginecología, doctora Charo, el taller de fisiotomía y fisiografía, ¿Sí? En donde se harían estos talleres presenciales que sí si conocen el salón que queda allá en la alcaldía, que es el que presta para algunos comites, y pudiésemos pues brindar esos espacios para hacer talleres teórico prácticos, ¿sí? Y además, protegerles a ellos el espacio de las guías institucionales, pues para que ellos también sean partícipes y parte de todo el proceso que se realiza en la institución. Este sería el cronograma, pero pues quería traer la consideración de ustedes en llevar a cabo este cronograma más las revisiones de temas que ellos harían por cada uno de sus rotaciones y ya lo adicional sería lo que acabamos de hablar que serían las grandes sesiones o atenidos clínicos. No sé si les parece bien en vez de llenarnos de tema y llenarnos pues nosotros también de actividades que tal vez sean un poco difíciles de cumplir como no es personal las oportunidades del año pasado. No sé qué les parece. Ah, yo les estoy presentando pantalla. Sí. Ahí tengo una duda que pena contigo, doctora Toledo.

45:46 - Oscar Lopez
En cuanto a los días de práctica, lo que ellos van a hacer es como las que ya está ajustada al hospital, que ya se tiene esto, es como una presentación que ellos hacen para dejar en el aula que tenemos ahora académica, para que la gente la revise y se pape de las guías de práctica clínica, ya no es como antes que hacíamos la guía y la presentábamos, como pasó con la despalla cardíaca, como se dice en la época, que citábamos a la gente y se les daba como el enfoque de la guía, se ponía en el El tema del apoyo del interno en lo que sucedió en febrero fue porque ningún especialista, lo que se me

46:40 - Academia investigación
informó, es que quería grabar el video. Por lo tanto, pues como teníamos que grabarlo con basura, entelación, porque eso lo tienen que editar por parte del equipo de comunicaciones, pues se le dio como el espacio al médico interno para que hiciera la grabación. Sin embargo, pues para la conexión interactiva y la evaluación, sí o sí tiene que estar conectado el especialista líder de esta guía, que en este caso, en caso de infección respiratoria aguda, es el doctor Carlos González. Para la metodología de este año, se va a hacer de la siguiente manera, y pues pronto aprovecho ese espacio para explicarles. Los segundos jueves de cada mes, ¿sí? Se debe proteger una hora al equipo asistencial, a los profesionales de salud, que son público objetivo de esa guía, para que ingresen a la plataforma educativa. Ya posteriormente ustedes recibirán la circular de ingreso y todo respectivamente. Ingresan a la plataforma. Revisar un video, que el video la intención es ser muy rápidos y concisos en el tema de las guías o puntos muy prácticos de la guía de práctica clínica adoptada por la institución y revisar los materiales de apoyo de esa guía. El siguiente jueves, es decir, el tercer jueves de cada mes, se va a hacer la conexión virtual. Se conecta el líder que hizo la grabación del video, se conecta personas que son el público objetivo de esa guía, la idea es que el líder de esa guía desarrolle un caso clínico y resuelva las preguntas que surgieron a partir del vídeo o a partir pues de la práctica diaria. La idea es abordarlo en dos tiempos diferentes, un tiempo va a ser para consulta externa porque los temas son completamente diferentes en consulta externa y otro tiempo es para urgencias a su hospitalización. Ese es el motivo por el cual ustedes van a encontrar que, por ejemplo, no sé si la subgerente les envió el cronograma completo del año en donde aparece la guía, el líder de la guía, cuál va a ser el público objetivo, ¿sí? Y pues lo que ustedes están viendo en pantalla cuál es la fecha de la revisión del material audiovisual en la

plataforma educativa y la fecha en donde se hace la conexión interactiva y la En el caso de los internos Doc Oscar, la idea es que ellos se unan a las sesiones de conexión interactiva INSTITUCIONAL para que sean parte de ese proceso de la socialización. Y, por supuesto, el segundo jueves de cada mes también protegerles a ellos el espacio para que puedan revisar el material educativo dentro de la plataforma INSTITUCIONAL. Es eso, doc. Gracias. Listo, doctor. Para no alargarnos tanto, quería comentarles las otras situaciones que nos comentaron los médicos internos, bueno, dentro de los comités de DOCENCIA y SERVICIO. Ellos dicen que han presentado como dificultad comunicación asertiva tanto con los médicos hospitalarios como con el personal de enfermería porque ellos pasan revista con el especialista, van y presentan los cambios con el equipo de enfermería y médico hospitalario como que nadie les presta atención a la situación y a las notas que ellos realizan y pues nuevamente después genera como esos conflictos pero con este personal específico. Este tema lo hablé con el doctor Ortiz Pues hace poco él tuvo su COMITÉ y pues como que va a presentar una actividad en donde ellos, si o si el médico hospitalario, la intención es que ellos también estén pasando revista con los especialistas. Y pues la jefe de enfermería del piso pues también tiene que estarlo haciendo de esa manera. Esta observación surge más en relación a todo lo de hospitalización, más que por el SERVICIO de urgencias o consulta externa. Lo del permiso académico. Ellos brindaron la observación yo creo que no he visto ningún problema de que no les den permiso sin embargo voy a estar como muy atenta o escribiéndoles en el grupo cuando hay cuando ellos tienen que asistir a alguna revisión como para que ustedes estén atentos pero yo les envío el cronograma previamente pues para que también estén al tanto y tengan conocimiento de esto y ya por último es una queja en relación a temas de condiciones de alimentación que ya se resolvieron con la doctora Tuleisi. Entonces, y ya. Doctores, hay algo que a nivel INSTITUCIONAL pues ya empezamos a realizar y a planear que es certificarnos como un enseñario de práctica clínica pues de hospital universitario, ¿sí? Y pues esto requiere bastante trabajo y varios aspectos, pero uno de los más importantes es en cuanto a los requisitos académicos para el docente asistencial, que en este caso serían ustedes. Por ejemplo, ¿qué se requeriría en que sean los coordinadores o en estos momentos que ustedes son los docentes líderes de cada área? Que se pudiese tener o maestría en educación, en salud pública o epidemiología o afines en estas áreas, y si no, puede ser un diplomado o curso en DOCENCIA universitaria. Con esto quiero decir, si alguno de ustedes no cuenta con ese diplomado un curso porque pues ya por parte de la Universidad de Boyacá y la Universidad de Medellín que la EIA me van a ofrecer estos cupos para estos diplomados. Entonces yo quiero saber si alguno de ustedes no cuenta con esos mismos o desean reforzarlos para ya tenerlos en cuenta para estos cupos que nos vayan a asignar. No sé si todos los tengan ya o se han visto.

52:53 - DAVID LEONARDO SANCHEZ
maestría y con el diploma también, pero hay que reforzar. Y mi grupo de cirujanos, absolutamente todos, incluyendo el doctor Pena. ¿Cuántos cirujanos son?

53:01 - Academia investigación
Son los cinco.

53:02 - DAVID LEONARDO SANCHEZ
Entonces, esos cinco, sí o sí, ya como una cuestión de coordinador de SERVICIO, a finales del año pasado les exigí que el hecho de que tuviéramos internos tenían que tener y capacitarse en cuestión de ausencia. Ellos estuvieron de acuerdo. Acuérdate que yo me acerqué a ti y te dije como que necesito que me colabores a ver con los cursos o con los grupos o algo así pues porque yo me comprometí con ellos a que yo les digamos como que les conseguía el acceso a eso pero el compromiso de ellos es que tenían que hacer todo eso. Entonces tengo mi grupo de cirugía general. Si o si DOCENCIA. Y yo repito.

53:41 - Academia investigación
¿Listo? ¿Listo? ¿O sea contigo serían 6?

53:43 - DAVID LEONARDO SANCHEZ
No, conmigo serían 5.

53:44 - Academia investigación

¿Listo? Ah, listo. Gracias. Yo por mi parte no tengo Lo confieso.

53:50 - Juan Camilo Morales Perez
¿Listo? Entonces, nada, si me pueden meter al grupo del CHEVRE.

53:55 - Academia investigación
Listo, listo mi amigo. Doctor Oscar, ¿tienes doctora de CHEVRE?

53:59 - Oscar Lopez
Yo tengo el contrario, hicimos el diplomado de la UPTC que se ofreció, el de diplomado en pedagogía y educación en escenarios clínicos. No sé si ese vale. Sí, ese vale, doctor.

54:14 - Academia investigación
Está dentro como de la dama de los de DOCENCIA universitaria, que son también educación en salud o educación en escenarios clínicos formativos, se llama así.

54:28 - Natalia Salas
Doctora Natalia. No, doctora, yo no tengo diplomado ni certificación.

54:34 - Academia investigación
¿Alguien más de pronto de tu área para capacitar y ya tener los grupos organizados?

54:42 - Natalia Salas
Pues déjame preguntar. Yo ya te confirmo mañana en el transcurso del día para poder, para los que estén interesados, ¿vale?

54:50 - Academia investigación
Visto que hoy van muy pendientes. Si algo nuevo, algo surge en esto, pues ya tengo a los que están acá en la reunión, ¿cómo sería? Ya tengo la reunión con las otras universidades hasta la tercera semana de febrero, porque estamos organizando el ingreso de varios estudiantes. Por eso no se ha hablado del tema Doc DAVID, pero yo ya lo tengo súper presente para la idea es que todos que estamos en todo este tema de internado en sí, pues sí o sí tenemos que tener algún curso diplomado en temas de DOCENCIA universitaria o en su caso también puede ser una maestría en educación, salud pública, epidemiología y sus afines. Entonces como para que lo tengamos en cuenta pues para ser parte de esa meta INSTITUCIONAL. Y ya para finalizar doctores quería preguntarle ¿Cómo están con el usuario de los médicos internos? Si ustedes ven algo inusual, hubo muchas dificultades entre diciembre y enero, pero ya todos los médicos internos me dijeron que está funcionando bien y que los especialistas están dando el aval. Quería confirmar pues esta información con ustedes si se está haciendo de esa manera. Por supuesto, los únicos que no tienen usuarios son los médicos internos de la Universidad de Medellín, pues porque ellos vienen solo un mes y se van. Entonces, no tendría sentido darles un usuario a ellos solamente por un mes. Es más, como los que ven, meses y el año.

56:17 - Oscar Lopez
El usuario de todos creo que está sirviendo bien. De mi parte, a veces yo hago notas porque me digo con ellos las notas. Entonces, lo que estoy haciendo es no entrar con el usuario de ellos, sino poniéndolas como en el encabezado de la evolución. Con nombre y apellido y abajo el mío como para dejar digamos constancia de que pasaron revista y que estuvieron como en la parte de la de la nota ¿por qué? Porque a veces uno llega y pues las prenotas no están y se demoran más mientras ellos la cargan entonces también eso a veces retrasa un poquito el que enfermería revise las notas personalmente enfermería alega un poquito en el contexto en el que como en el día hasta las 4 o 5 creo que tengo entendido hay dos jefes, una de medicamentos y una del SERVICIO general, entonces ellas dicen que pues las notas por lo que solicitan es que estén antes de media para que una de las jefes se siente a revisar las notas, los cambios hechos y que no les quede como tan tarde para revisar ese tipo de situaciones, entonces por eso yo a veces cojo algunos pacientes, los hago yo y al interno le pido el favor de que suba las notas, pero en general creo que los usuarios han servido bien y ya no aparecen con errores como como a

principio de cuando se hizo como la prueba del ingreso de ellos al sistema e independientemente que queden por ejemplo cuando sean las salidas ellos quedan apoyando ahí por ejemplo la cita por medicina interna pero creo que eso no tiene relevancia porque igual va al sello del especialista entonces y no tienen como como a cargo sin no solamente el número de documento y ya.

58:02 - Academia investigación
Listo, te agradezco entonces eso. El siguiente punto es en cuanto a calificaciones. Yo les quiero proponer que durante este semestre los médicos internos no les pasen a ustedes las hojitas como en la misma dinámica que veníamos antes, sino que estaré yo escribiéndoles a cada uno de ustedes pues cuánto es la nota respectiva. Pues para evitar cargar papeles y yo también sistematizar las calificaciones de una manera más rápida. No sé si les parece bien de pronto que les pueda llamar o preguntarles por WhatsApp una nota, pues en vez de que el médico interno vaya detrás de ustedes con el la hojita ahí detrás. Entonces, si les parece bien que les esté preguntando.

58:49 - Natalia Salas
Sí, como sea, por mí no hay lío.

58:51 - Academia investigación
Sí, está de acuerdo. Vale. Y ahora para finalizar, solamente para En cirugía general, todos van a llegar.

58:58 - DAVID LEONARDO SANCHEZ
O sea, yo te paso la nota por whatsapp, pero también lo va a pasar el examen. Si no estás en el examen, no es completa. Listo? Hasta que no. Yo ya tengo los de diciembre, enero y ya guardamos día examen. Entonces, hasta que no tengan nota examen, pues no te los paso. Listo?

59:24 - Oscar Lopez
Apoyo, DAVID, yo creo que también a partir de, no este mes, pero de pronto, de pronto, marzo, abril, voy a empezar a hacer examen también porque necesito mirar cómo está, evaluarles el conocimiento de lo aprendido durante la rotación. Porque si veo algunas falencias en ellos, a veces en la revista se ponen muy dispersos o sacan el celular para consultar lo que uno les pregunta durante la revista, que ya son cosas básicas a las que ellos deberían manejar. Sí, exacto. Entonces, creo que sí voy a empezar también con la metodología de un examen general para los votantes de medicina interna. Listo, doctor.

1:00:01 - Academia investigación
Entonces, teniendo en cuenta que va a haber este cambio en metodología, yo lo voy a buscar en un momentico para que en el plan académico que se deja de internado, cierto, que se hace por año, dejamos esa instauración de que se va a realizar evaluación y quede como escrito en para la nota final y pues listo, ahí ya resolveremos eso. Entonces yo les voy a escribir a los dos para que nos sentemos un momentico y organicemos ese plan académico. No sé si por parte de la Dra. Natalia y el Dr. Juan Camilo también van a ir a, vayan a decidir realizar evaluación o me comentarán en el transcurso del mes si va a haber cambio en la metodología durante la rotación de sus áreas. Y Dr. Juan Camilo, en cuanto a los internos. Sin embargo, sí, como obligatoria, sí tenemos por parte la UPTC rotar sí o sí por urgencias. Entonces, todos los que tengan UPTC sí o sí van a rotar por urgencias. En el caso de Univoy acá, no fue parte de las obligaciones porque ellos me regalaron como un temario específico, pero ahorita que tengo el COMITÉ de DOCENCIA de SERVICIO, lo voy a dejar ya como instaurado para que pueda ser utilizado. Sí. Sí.

1:01:45 - Academia investigación
que posteriormente pues ya se hará como una socialización de ese COMITÉ para que ustedes lo conozcan y sepan cómo pasar proyecto de investigación si se va a utilizar pues datos del hospital que son súper accesibles es muy fácil y pues evidentemente el COMITÉ por situaciones pues quieres empezar a tener poco más de productos de investigación entonces quédense muy atentos si van a desarrollar alguno ya ustedes como docentes Así que estaré muy atento si necesitan este apoyo por parte del COMITÉ, por parte mía y por parte de la universidad. Entonces, eso es todo lo que sé.

1:02:43 - Academia investigación
A petición del investigador, generalmente los comités de ética de investigación es una vez cada semestre, pero existen comités extraordinarios, Doc, que es en el momento en que se van a presentar los proyectos de investigación, pues en una fecha diferente al COMITÉ ordinario. Gracias, doctora. Listo. Listo. Doctores, y ya para finalizar, pues yo les quiero proponer si al menos estos espacios a todos es mejor, ¿por qué?

1:03:35 - Oscar Lopez
Porque vamos afianzando un poquito y digamos lo que hagamos de refuerzo en la metodología de enseñanza de aprendizaje o las valencias que le dimos a los internos también, pues ponerlo en conocimiento porque creo que si reforzamos esto para todas las especialidades va a ser mejor. Si yo tengo el interno en medicina interna del siguiente me va a rotar por cirugía, pues ya que vaya con unas bases fuertes, no solo en la parte académica, sino también con la parte asistencial, en la parte de presentar los pacientes, de tener como esa rapidez de construir digamos que el análisis de los pacientes.